Compréhension de texte **Serie 5 - 2025**

18 Exercices - 45 Minutes

Texte pour les questions 1) - 6)

Le pharynx, un tube musculaire de 12 à 15 cm de long, s'étend de l'os occipital à la 6e vertèbre cervicale. Il se divise en trois parties : l'épipharynx, le mésopharynx et l'hypopharynx. L'épipharynx est situé en face des cavités nasales et est relié à celles-ci par les choanes. Il s'étend de la base du crâne jusqu'au palais mou et contient la trompe auditive. Celle-ci présente un renflement, le torus tubarius, et peut être ouverte par le muscle salpingopharyngé, le muscle tenseur du voile du palais et le muscle releveur du voile du palais, ce qui permet l'équilibrage de la pression et la ventilation de l'oreille moyenne. Les deux muscles veli palatini forment un triangle, le levator représentant l'hypoténuse et le tensor représentant l'ancatète et la contre-catète. Le tensor s'enroule autour de l'hamulus pterygoideus (hypomochlion). Le mésopharynx est relié à la cavité buccale par l'isthme faucium, délimité par l'arc palatopharyngé et l'arc palatoglossé. Il s'étend du palais mou à l'épiglotte et comprend également la vallécule épiglottique, des creux situés à côté de l'épiglotte. La partie inférieure, l'hypopharynx, est reliée au larynx par l'aditus laryngeus et abrite le recessus piriformis, par lequel les aliments parviennent dans l'œsophage. L'œsophage représente la transition caudale du pharynx. Le ramus internus du nerf laryngé supérieur passe directement sous sa muqueuse.

La paroi du pharynx est formée de trois muscles, tous innervés par le nerf glossopharyngien (IX) et le nerf vague (X) via le plexus pharyngé, ainsi que par la membrane pharyngobasilaire. De haut en bas, on trouve : le muscle constricteur supérieur du pharynx, le muscle constricteur moyen du pharynx et le muscle constricteur inférieur du pharynx. Ce dernier s'étend jusqu'au larynx et présente souvent un triangle musculaire faible, le triangle de Killian. Les trois muscles pharyngés appariés, qui se chevauchent comme des tuiles, se rejoignent dorsalement dans le raphé pharyngé.

D'autres muscles servent à soulever le pharynx lors de la déglutition : le muscle stylopharyngé prend naissance au niveau du processus styloïde et s'étend entre le muscle constricteur supérieur et moyen du pharynx jusqu'à la paroi latérale du pharynx. C'est le muscle conducteur du nerf glossopharyngé (IX). Le muscle palatopharyngé s'étend du palais mou à la paroi latérale du pharynx et au cartilage thyroïdien. Le muscle salpingopharyngé est un muscle fin qui s'étend du bord libre du cartilage tubaire à la paroi latérale du pharynx. Au début de l'œsophage, entre la musculature annulaire et la musculature longitudinale s'étendant latéralement, se trouve le triangle de Laimer. Le pharynx est séparé dorsalement de la musculature prévertébrale (muscle long du cou et de la tête) et de la colonne vertébrale par l'espace rétropharyngé. L'espace rétropharyngé se prolonge distalement dans l'espace rétro-œsophagien et se termine au niveau du diaphragme. Le côté du pharynx est occupé par l'espace latéro-pharyngé, dans lequel passent les nerfs crâniens IX, X, XI, XII ainsi que la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne.

L'espace latéro-pharyngé est divisé par le diaphragme styloïde en un espace pré-styloïde et un espace rétro-styloïde. Le pré-styloïde contient les artères palatines ascendante et descendante, le rétro-styloïde les vaisseaux et les nerfs qui quittent la base du crâne par les ouvertures suivantes : le canal hypoglosse (pour le nerf hypoglosse - XII), le foramen jugulaire (pour le nerf glossopharyngien - IX, le nerf vague - X,

CC BY NC 1nc-wiki.ch

nerf accessoire - XI, veine jugulaire interne), le canal carotidien (pour l'artère carotide interne) ainsi que d'autres structures telles que le tronc sympathique, l'artère occipitale (qui provient de l'artère carotide externe, passe derrière le ventre postérieur du muscle digastrique vers le côté de l'os occipital) et les branches terminales de l'artère pharyngée ascendante (qui provient également de l'artère carotide externe, passe vers le côté en direction du pharynx).

Le nerf hypoglosse passe dorsalement au niveau du nerf vague et traverse le triangle carotidien entre le muscle hyoglosse et le muscle mylo-hyoïdien. Il innerve de manière somatomotrice les muscles de la langue à l'aide de fibres provenant du noyau du nerf hypoglosse : muscle styloglosse, muscle génioglosse et muscle hyoglosse. Sur le plan clinique, il est important de noter qu'en cas de trouble de l'innervation, la langue dévie vers le côté atteint. De plus, les fibres de l'ansa cervicalis profunda (radix superior) s'attachent au nerf hypoglosse et le suivent brièvement avant de se ramifier et d'innerver soit directement le muscle geniohyoïdien et le muscle thyrohyoïdien, soit indirectement, via l'ansa cervicalis profunda, le reste de la musculature infrahyoïdienne (muscle omohyoïdien, muscle sterno-hyoïdien, muscle sternothyroïdien) via l'ansa cervicalis profunda.

CC BY NC

1) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas** être déduite du texte ?

(A) Le nerf glossopharyngien tire avec son muscle conducteur, le muscle stylopharyngien, vers la paroi latérale du pharynx.

(B) Le muscle tenseur du voile du palais s'enroule autour de l'hamulus pterygoideus et ouvre la trompe auditive avec deux autres muscles.

(C) Le muscle constricteur inférieur du pharynx peut entourer le triangle de Killian, une zone de faiblesse musculaire dans la région de l'hypopharynx.

(D) Le nerf laryngé supérieur passe directement sous la muqueuse du mésopharynx.

(E) Les trois muscles du pharynx se chevauchent comme des tuiles et innervent dorsalement le raphé pharyngé.

2) Quelles affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Le recessus piriformis fait partie de l'hypopharynx et achemine les aliments vers l'œsophage.
II. Le muscle stylopharyngus est innervé par le nerf vague.
III. Les valeculae epiglotticae se trouvent dans le mésopharynx.
IV. L'artère palatine descendante se trouve dans l'espace praestyloïdien.

(A) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.

(B) Seules les affirmations II et IV peuvent être déduites.

(C) Seules les affirmations I, II et III peuvent être déduites.

(D) Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.

(E) Les quatre affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC 3nc-wiki.ch

3) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas** être déduite du texte ?

(A) L'épipharynx s'étend de la base du crâne jusqu'au palais mou et communique avec la cavité nasale par les choanes.
(B) Le muscle stylopharyngien traverse le triangle de Laimer pour atteindre la paroi latérale du pharynx.
(C) L'isthme faucial est délimité par l'arc palatoglossus et l'arc palatopharyngeus.
(D) Le muscle salpingopharyngé prend naissance au niveau du cartilage tubaire et s'étend jusqu'à la paroi latérale du pharynx.
(E) L'hypopharynx est relié au larynx par l'aditus laryngeus.

4) Parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles pouvant être déduites ?

I. Les trois étages du pharynx se distinguent tant par leur emplacement que par leurs connexions avec les organes voisins.
II. Le plexus pharyngé est exclusivement constitué de fibres du nerf vague.
III. L'espace rétro-œsophagien se prolonge caudalement à partir de l'espace rétropharyngé.
IV. Le nerf hypoglosse passe entre deux muscles de la langue à travers le triangle carotidien.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
B) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
C) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
D) Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
E) Les quatre affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

5) Quelles affirmations ne peuvent **pas être** déduites du texte ?

I. Le canal carotidien se trouve dans l'espace rétrostyloïdien.
II. L'artère pharyngée ascendante s'étend en direction du pharynx.
III. Le tronc sympathique passe dans l'espace rétrostyloïdien.
IV. Le nerf vague passe en avant du nerf hypoglosse.

(A) Seule l'affirmation IV ne peut pas être déduite.
(B) Seules les affirmations II et IV ne peuvent pas être déduites.
(C) Seules les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites.
(D) Seules les affirmations I, III et IV ne peuvent pas être déduites.
(E) Les quatre affirmations ne peuvent pas être déduites.

6) Quelles affirmations peuvent être déduites du texte ?

I. La musculature infra-hyoïdienne peut être influencée indirectement par le nerf hypoglosse via les fibres de l'ansa cervicalis profunda.
II. Le muscle hyoglossus est situé en position médiale par rapport au muscle mylo-hyoïdien.
III. En cas de défaillance du nerf hypoglosse, la langue dévie vers le côté affecté.
IV. La racine supérieure de l'ansa cervicalis profunda s'attache temporairement au nerf hypoglosse.

(A) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(B) Seules les affirmations II et IV peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations I, II et III peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
(E) Les quatre affirmations peuvent être déduites.

5nc-wiki.ch

Texte pour les questions 7) - 12)

Toutes les cellules du corps humain contiennent exactement le même ADN, mais leurs fonctions sont très différentes. Le processus de différenciation cellulaire confère aux cellules leurs propriétés structurelles, morphologiques et fonctionnelles spécifiques. Les facteurs extrinsèques qui influencent ce processus sont les hormones, les facteurs de croissance, les facteurs de différenciation et les interactions cellulaires. Sous l'influence de facteurs de transcription spécifiques au type de cellule (« facteurs intrinsèques »), des modifications de l'expression génétique se produisent également. De plus, des modifications épigénétiques permettent de maintenir l'état activé ou réprimé d'un gène pendant les divisions cellulaires et les phases de différenciation. Une modification épigénétique décrit le changement structurel des régions de chromatine qui permettent la détection, le marquage ou le maintien d'états modifiés de l'activité génétique. Concrètement, cela signifie que toutes les cellules contiennent en principe l'intégralité de l'ADN, mais que des facteurs intrinsèques et des modifications épigénétiques permettent une lecture différenciée du génome. Dans les cellules, de nombreuses protéines sont liées au brin d'ADN. Ce complexe ADN-protéine est appelé chromatine. Les protéines histones, autour desquelles s'enroule le brin d'ADN, sont particulièrement nombreuses.

L'état de condensation de la chromatine peut varier d'une cellule à l'autre. Les régions dans lesquelles la chromatine est fortement condensée sont généralement inactives en termes de transcription. Les gènes qu'elles contiennent ne peuvent donc pas être lus. On parle ici d'hétérochromatine. L'euchromatine, en revanche, désigne la chromatine qui est à peine condensée. Cet état lâche permet la liaison de facteurs de transcription aux régions promotrices de l'ADN. La liaison des facteurs de transcription à la région promotrice d'un gène active sa transcription. Ces états variables de condensation de la chromatine dépendent fortement des modifications épigénétiques de l'ADN ou des protéines histones. Cependant, la séquence d'ADN reste toujours inchangée et les modifications épigénétiques sont en principe réversibles. Les protéines histones sont soumises à quatre types de modifications épigénétiques : l'acétylation, la méthylation, la phosphorylation et l'ubiquitination. Lors de l'acétylation, un groupe acétyle est lié à l'histone via HAT (histone acétyltransférase), ce qui entraîne un relâchement de la chromatine. Le groupe acétyle peut être à nouveau éliminé par l'HDAC (histone désacétylase). Une modification épigénétique importante de l'ADN est l'ajout de groupes méthyles à la cytosine qui précède une guanine. Ces cytosines particulières sont abrégées par CpG. Les régions promotrices contiennent souvent un nombre particulièrement élevé de CpG, c'est pourquoi on parle également d'îlots CpG. La méthylation des CpG dans les régions promotrices entraîne la liaison de complexes protéiques spécifiques (MPB) qui inhibent l'action des facteurs de transcription et empêchent ainsi la transcription des gènes suivants. De plus, les MPB recrutent des HDAC, ce qui entraîne la désacétylation des histones. L'activité transcriptionnelle est ainsi fortement réduite dans les régions d'ADN hyperméthylées.

L'empreinte parentale est un phénomène résultant de la méthylation de l'ADN. Dans les cellules, la grande majorité des gènes sont exprimés à la fois par les copies paternelles et maternelles (allèles). Cependant, dans le cas des gènes dits « imprimés », seul l'un des deux allèles est exprimé. Cela est dû à la méthylation différente des allèles parentaux. Ainsi, le gène supprimé est hyperméthylé, tandis que l'autre est hypométhylé. Cette méthylation de l'ADN est très stable et est conservée même lors de la division cellulaire. Des défauts dans l'expression de ces gènes imprimés peuvent entraîner des pathologies du développement ou des cancers. Les syndromes de Beckwith-Wiedemann et de Silver-Russell, qui résultent de défauts épigénétiques dans la même région chromosomique (11p15), en sont

CC BY NC 6nc-wiki.ch

des exemples. Cette région chromosomique 11p15 contient deux gènes : Igf2 et H19. Igf2 code pour une protéine qui favorise la croissance et H19 pour un ARN non codant ayant une fonction anti-prolifération. Entre ces deux gènes se trouve une région CpG island. Dans l'allèle maternel, l'îlot CpG est hypométhylé. Cela permet la liaison du complexe CTCF, qui rend possible la transcription du gène H19 et désactive le gène Igf2. Dans l'allèle paternel, l'îlot CpG est hyperméthylé et le CTCF ne peut pas se lier. Le gène H19 est alors inactivé et le gène Igf2 est transcrit. Dans le syndrome de Beckwith-Wiedemann, l'îlot CpG est hyperméthylé sur les deux allèles. Les deux copies du gène Igf2 sont alors exprimées et le gène H19 est complètement inactif. Il en résulte une croissance excessive. Dans le syndrome de Silver-Russell, en revanche, l'îlot CpG est inactif sur les deux allèles, ce qui entraîne un retard de croissance.

CC BY NC

7) Laquelle des affirmations suivantes ne peut **pas être** déduite du texte ?

(A) Toutes les cellules du corps humain contiennent les mêmes informations génétiques.

(B) La différenciation des cellules dépend des hormones.

(C) Les modifications épigénétiques sont perdues lors de la division cellulaire.

(D) Les gènes peuvent être activés ou réprimés.

(E) La transcription d'un gène est régulée par des régions promotrices.

8) Laquelle / lesquelles des affirmations suivantes est/sont correcte(s) ?

I. La méthylation de l'ADN diffère chez les parents.

II. L'allèle réprimé est hypométhylé.

III. Les gènes imprimés entraînent des pathologies du développement.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I est correcte.
(C) Seule l'affirmation III est correcte.
(D) Les affirmations II et III sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

9) Laquelle des affirmations suivantes concernant la méthylation de l'ADN est correcte ?

(A) Un groupe méthyle est ajouté à une guanosine.

(B) La méthylation de l'ADN a un effet indirect sur la méthylation des histones.

(C) L'activité transcriptionnelle est élevée dans les régions hyperméthylées.

(D) La méthylation de l'ADN est réversible.

(E) Les CpG sont toujours méthylés.

CC BY NC

10) Laquelle des affirmations suivantes concernant le syndrome de Beckwith-Wiedemann est fausse ?

Dans le syndrome de Beckwith-Wiedemann...

(A) Il y a une croissance excessive.

(B) Le CTCF peut se lier aux deux allèles.

(C) Le gène Igf2 est transcrit sur les deux allèles.

(D) L'îlot CpG est hyperméthylé.

(E) Il s'agit d'un défaut d'empreinte parentale.

11) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

I. L'enzyme HAT participe à l'acétylation des histones.

II. HDAC participe à la méthylation de l'ADN.

III. Les histones font partie de la chromatine.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(D) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

12) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

I. Un défaut épigénétique dans la région chromosomique 11p15 entraîne toujours un retard de croissance.

II. Le gène maternel Igf2 est activé dans des circonstances normales.

III. Pour la majorité des gènes, seule une copie du gène (maternel ou paternel) est transcrite de manière active.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(D) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

Texte pour les questions 13) - 18)

L'oreille moyenne est composée de la trompe auditive, des cellules mastoïdiennes et de la cavité tympanique (cavitas tympani). La cavité tympanique contient trois osselets : le marteau, l'enclume et l'étrier. La cavité tympanique peut être divisée topographiquement en épitympan (au-dessus de la membrane tympanique, le tympan), mésotympan (parallèle au tympan) et hypotympan. Les osselets, qui sont reliés entre eux, amplifient le signal du tympan de 17 fois. La tête du marteau et de l'enclume sont reliées entre elles par une articulation en selle (amphiarthrose), l'articulation incudomalléolaire. Le manubrium du marteau repose sur le tympan. Au total, le marteau dispose de trois ligaments : le ligament antérieur du marteau, le ligament supérieur du marteau (au niveau du toit) et le ligament latéral du marteau (au niveau de la paroi latérale). La tête de l'enclume s'articule avec le marteau. L'enclume possède deux branches s'étendant vers le bas, le crus longum et le crus breve, le crus longum se transformant en processus lenticulaire et s'articulant avec l'étrier dans l'articulation incudostapédienne, une articulation sphérique plate. L'enclume possède deux ligaments : le ligament postérieur de l'enclume (du crus breve à la paroi latérale) et le ligament supérieur de l'enclume (au niveau du toit). La tête de l'étrier s'articule avec l'enclume. L'étrier est prolongé par un crus antérieur et un crus postérieur qui convergent vers le bas dans la base de l'étrier. La base de l'étrier est reliée à la fenêtre vestibulaire par le ligament annulaire de l'étrier, qui est mobile. Toutes les structures de l'oreille moyenne sont recouvertes d'une couche muqueuse.

La cavité tympanique, légèrement inclinée, présente six parois : la paroi latérale (paries membranaceus) est principalement formée par le tympan. Le muscle tenseur du tympan, qui prend naissance dans la partie verticale du canal facial à partir du nerf facial, s'insère ici au niveau du manubrium mallei. Il s'étend dans un pli muqueux, la plica mallearis posterior, accompagné de l'artère tympanique postérieure, entre le marteau et l'enclume à travers la cavité tympanique vers le côté et le long de la plica mallearis anterior jusqu'à la fissure pétro-tympanique. La paroi médiale (paries labyrinthicus) est adjacente à l'oreille interne et est en grande partie délimitée par le promontoire, formé par la cochlée. Le plexus tympanique, composé du nerf tympanique (une branche du 9e nerf crânien, le nerf glossopharyngien, avec des fibres provenant du noyau salivateur inférieur), se trouve sur le promontoire. Ces fibres se prolongent à travers le hiatus du canal du nerf pétrosien mineur sous la forme du nerf pétrosien mineur et passent par la fissure sphéno-pétrosienne en direction du ganglion otique, où les fibres parasympathiques sont commutées. Le nerf suit ensuite le nerf auriculotemporal du nerf maxillaire jusqu'à la parotide, qu'il innerve également.

Au-dessus du promontoire se trouve la fenêtre vestibulaire, fermée par la base de l'étrier. Sur le côté, la partie horizontale du canal facial (prominence du canal facial) dans laquelle passe le nerf facial fait saillie. Plus haut, le canal semi-circulaire latéral (ductus semicircularis lateralis) forme une protubérance dans la paroi et constitue la proéminence du canal semi-circulaire latéral (prominentia canalis semicircularis lateralis). Dans la partie postérieure inférieure de la paroi médiale se trouve la fenêtre cochléaire (fenestra cochleae) en forme de rein, qui est fermée par la membrane tympanique secondaire (membrana tympanica secundaria) et sert à équilibrer la pression entre l'oreille interne remplie de liquide et l'oreille moyenne remplie d'air. Devant la fenêtre vestibulaire se trouve le processus cochléiforme, autour duquel le tendon du muscle tenseur du tympan (innervé par le nerf mandibulaire) s'incurve vers le côté. Derrière le sinus tympanique, on aperçoit l'éminence pyramidale, à la surface antérieure de laquelle le tendon du

CC BY NC

muscle stapédien sort et se dirige vers la tête de l'étrier. Ces deux muscles servent de réflexes protecteurs pour atténuer les bruits forts.

La paroi supérieure (paries tegmentalis) est constituée d'une fine plaque osseuse, le tegmen tympani, qui sépare la cavité tympanique de la fosse crânienne moyenne. La paroi inférieure (paries jugularis) est adjacente au bulbus superior de la veine jugulaire interne, le point le plus profond de la cavité tympanique. C'est ici que le nerf tympanique pénètre dans la cavité tympanique avec l'artère tympanique inférieure à travers le canal tympanique. La paroi antérieure (paries caroticus) est adjacente au canal carotidien et contient l'ouverture de la trompe auditive ainsi que l'entrée du muscle tenseur du tympan. C'est là que débouche le canal musculo-tubaire, qui est divisé par une fine lamelle osseuse en le semi-canal de la trompe auditive, dans lequel se trouve la trompe auditive avec l'ostium tympanique de la trompe, et le semi-canal du muscle tenseur du tympan, dans lequel se trouve le muscle tenseur du tympan. La paroi postérieure (paries mastoideus) passe par l'antrum mastoideum pour rejoindre les cellules mastoïdiennes (cellulae mastoideae).

11nc-wiki.ch

13) Quelle affirmation **ne peut pas** être déduite du texte ?

(A) La trompe d'Eustache relie la cavité tympanique au nasopharynx et sert à équilibrer la pression.

(B) L'articulation incudostapédienne est une articulation sphérique plate située entre l'enclume et l'étrier.

(C) Le nerf tympanique provient du nerf glossopharyngien et forme le plexus tympanique.

(D) Le nerf facial innerve le muscle tenseur du tympan.

(E) La paroi latérale de la cavité tympanique est principalement constituée de la membrane tympanique.

14) Lesquelles des affirmations suivantes ne peuvent **pas être** déduites du texte ?

I. La cavité tympanique est tapissée de muqueuse et jouxte l'oreille interne.

II. La fenêtre cochléaire est fermée par la membrane tympanique secondaire et permet la compensation de pression.

III. Le muscle stapédien s'insère sur le manubrium du marteau et régule la transmission du son.

IV. La base de l'étrier est reliée à la fenêtre cochléaire par le ligament annulaire stapédien.

(A) Seule l'affirmation I ne peut être déduite
(B) Seule l'affirmation III ne peut être déduite
(C) Seules les affirmations I, II et III ne peuvent être déduites
(D) Seules les affirmations III et IV ne peuvent être déduites
(E) Les quatre affirmations ne peuvent être déduites

15) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Le plexus tympanique se trouve sur le promontoire et se prolonge sous la forme du nerf pétros mineur.

II. Le nerf facial innerve la muqueuse de la cavité tympanique.

III. Certaines parties du muscle tenseur du tympan s'incurvent autour du processus cochléiforme.

IV. La cavité tympanique est adjacente à l'oreille interne par sa paroi médiale.

(A) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(B) Seules les affirmations II et IV peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations II, III et IV peuvent être déduites.
(E) Les quatre affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC 12nc-wiki.ch

16) Selon le texte, laquelle des affirmations suivantes **n'est pas** correcte ?

(A) Le nerf petit pétrosien conduit les fibres parasympathiques vers le ganglion otique.

(B) Le nerf tympanique contient exclusivement des fibres sensorielles.

(C) Le nerf facial passe dans un canal le long de la paroi médiale de la cavité tympanique.

(D) Le promontoire est formé par les spires de la cochlée.

(E) L'artère tympanique postérieure traverse la cavité tympanique.

17) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Le nerf facial passe dans le canal facial au-dessus de la fenêtre vestibulaire et de la fenêtre cochléaire.

II. L'artère tympanique inférieure pénètre dans la cavité tympanique par la fissure pétro-tympanique.

III. La cavité tympanique est adjacente au bulbus superior de la veine jugulaire interne.

IV. Der Musculus tensor tympani wird von einem Ast des Nervus mandibularis innerviert.

(A) Seulement I et II
(B) Seulement II et IV
(C) Seulement I, III et IV
(D) Seulement I, II et III
(E) Les quatre affirmations

18) Laquelle des conséquences suivantes est la plus probable en cas de fracture de la fissure pétro-tympanique ?

(A) Une atteinte de l'artère tympanique postérieure, qui passe par la cavité tympanique.

(B) Une lésion de l'éminence pyramidale avec paralysie du muscle stapédien.

(C) Une lésion du nerf tympanique avec perturbation du plexus tympanique.

(D) Un blocage de la fenêtre vestibulaire par luxation de l'étrier.

(E) Une hémorragie dans le canal facial avec paralysie faciale complète.

CC BY NC

Réponses:

1) D
2) D
3) B
4) A
5) A
6) D
7) C
8) B
9) D
10) B
11) D
12) E
13) A
14) D
15) C
16) B
17) C
18) A

14nc-wiki.ch